

1. Introducción y relevancia clínica

El diagnóstico en psiquiatría se basa en **criterios clínicos** estructurados y en la observación sistemática de síntomas psicológicos, conductuales y biológicos.

A diferencia de otras especialidades, no existen **biomarcadores específicos** para las enfermedades mentales, por lo que los sistemas clasificatorios estandarizados son fundamentales para:

- Asegurar **uniformidad diagnóstica** entre clínicos.
- Facilitar la **comunicación interdisciplinaria** y la investigación.
- Guiar las **decisiones terapéuticas** y el **acceso a programas de salud** (como GES y MINSAL).

Los dos sistemas más usados internacionalmente son:

- **CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades, OMS).**
- **DSM-5 (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, APA).**

☐ En el **EUNACOM**, se evalúa la capacidad del médico para **reconocer los criterios diagnósticos** más importantes, distinguir entre ambos sistemas y aplicar el enfoque sindromático en casos clínicos.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. CIE-10

El **CIE-10** es el sistema oficial adoptado por la **OMS** y utilizado por el **Ministerio de Salud de Chile** para la codificación diagnóstica.

Incluye los trastornos mentales dentro del **Capítulo V (F00–F99)** y se basa en un **modelo descriptivo y clínico**, más que etiológico.

- Agrupa los trastornos según **síntomas predominantes**.
- Promueve un enfoque **transcultural** (aplicable globalmente).

- Cada diagnóstico posee **criterios operacionales mínimos**.

Ejemplo:

- **F32.x – Episodio depresivo:** requiere síntomas depresivos durante al menos 2 semanas, con intensidad suficiente para alterar el funcionamiento.

El **CIE-11**, versión más reciente, mantiene la estructura general pero introduce:

- Enfoque más dimensional.
 - Mayor claridad en la definición de duración y gravedad.
 - Inclusión de categorías como **trastorno mixto de ansiedad y depresión**.
-

2.2. DSM-5

El **DSM-5** (American Psychiatric Association, 2013) es más detallado y ampliamente utilizado en docencia e investigación.

A diferencia del CIE, el DSM se centra en **criterios operacionales precisos** para cada trastorno.

Características:

- Definiciones basadas en evidencia clínica y estadística.
 - Criterios A, B, C... estructurados según número y duración de síntomas.
 - Enfoque **descriptivo y ateórico** (no depende de una causa única).
 - Introduce la **evaluación dimensional** de síntomas (por ejemplo, gravedad de ansiedad o depresión).
 - Elimina el antiguo sistema multiaxial del DSM-IV.
-

2.3. Comparación conceptual

Aspecto	CIE-10	DSM-5
---------	--------	-------

Organismo	OMS	APA (EE.UU.)
Alcance	Global, sanitario	Clínico, docente e investigativo
Criterios	Más flexibles, descriptivos	Más estructurados y específicos
Estructura	Por categorías diagnósticas (F00–F99)	Por grupos clínicos (trastornos del ánimo, ansiedad, etc.)
Uso en Chile	Oficial (MINSAL)	Complementario, docente
Actualización	CIE-11 (2022)	DSM-5-TR (2022, revisión textual)

En práctica clínica chilena: **CIE-10 para codificación y GES, DSM-5 para docencia, investigación y precisión clínica.**

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

El diagnóstico psiquiátrico sigue un **razonamiento clínico escalonado**, que parte del **síntoma individual**, progresa al **síndrome** y finalmente a un **trastorno específico**.

3.1. Enfoque sindromático

Los síntomas psiquiátricos no son exclusivos de un trastorno.

Por ejemplo:

- La **anhedonia** puede aparecer en depresión mayor, esquizofrenia o consumo de sustancias.
- La **ansiedad** puede ser parte de un cuadro adaptativo, fóbico o depresivo.

Por ello, el clínico debe integrar:

- Duración y contexto.

- Grado de disfunción.
 - Presencia o ausencia de síntomas psicóticos, afectivos o somáticos.
-

3.2. Ejemplo práctico comparativo

Depresión mayor (DSM-5):

Criterios diagnósticos (≥5 de los siguientes durante ≥2 semanas):

1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día.
2. Pérdida de interés o placer.
3. Cambios en peso o apetito.
4. Insomnio o hipersomnia.
5. Agitación o retardo psicomotor.
6. Fatiga o pérdida de energía.
7. Sentimientos de inutilidad o culpa excesiva.
8. Disminución de la concentración.
9. Pensamientos de muerte o suicidio.

Al menos uno debe ser ánimo deprimido o pérdida de interés.

Debe causar **malestar clínico significativo** y no explicarse por sustancias o enfermedad médica.

Episodio depresivo (CIE-10):

- Requiere **≥2 síntomas nucleares** (ánimo depresivo, anhedonia, fatiga).
 - 2 a 4 síntomas adicionales.
- Duración mínima: **2 semanas**.
- Clasificación por gravedad: leve, moderado, grave.

□ **Conclusión:** ambos sistemas coinciden clínicamente, pero el **DSM-5** es más operativo y el **CIE-10** más adaptable a la codificación.

3.3. Diagnóstico diferencial:

1. Trastornos orgánicos (encefalopatías, endocrinopatías, efectos farmacológicos).
 2. Trastornos por sustancias.
 3. Trastornos afectivos primarios vs secundarios a enfermedades médicas.
 4. Síntomas simulados (malingering, facticio).
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Si bien el diagnóstico psiquiátrico es clínico, los exámenes ayudan a **descartar causas orgánicas o tóxicas**.

4.1. Exámenes recomendados según Guía MINSAL 2022:

- Hemograma, glicemia, perfil tiroideo, B12, ácido fólico.
- Tóxicos en orina.
- Neuroimagen (TAC o RM cerebral) en sospecha de etiología neurológica o deterioro cognitivo.
- EEG si sospecha de crisis epilépticas parciales o encefalopatía.

4.2. Herramientas psicométricas

- **MINI International Neuropsychiatric Interview (MINI):** entrevista estructurada breve.
- **PHQ-9 y GAD-7:** pesquisa de depresión y ansiedad en APS.
- **Escalas de Hamilton, Young y PANSS:** cuantificación de severidad en depresión, manía y psicosis.

En el contexto EUNACOM y APS chilena, se recomienda utilizar **PHQ-9** para depresión y **GAD-7** para ansiedad generalizada, según guías MINSAL 2023.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El **diagnóstico preciso** orienta directamente la elección del tratamiento farmacológico y psicoterapéutico.

Los programas de salud mental en Chile (GES, AUGÉ) se basan en criterios CIE-10.

5.1. Principios generales

1. **Confirmar diagnóstico clínico.**
2. **Evaluar gravedad** (leve, moderada, severa).
3. **Identificar comorbilidades** psiquiátricas y médicas.
4. **Elegir tratamiento según guías GES/MINSAL:**
 - ISRS como primera línea para trastornos afectivos y ansiosos.
 - Estabilizadores (litio, valproato, lamotrigina) para bipolaridad.
 - Antipsicóticos atípicos (olanzapina, risperidona, quetiapina) para esquizofrenia.
 - Psicoterapia cognitivo-conductual (TCC) como complemento fundamental.

5.2. En atención primaria (APS)

- Diagnóstico inicial y derivación si cuadro grave o refractario.
 - Registro CIE-10 en ficha clínica.
 - Derivar a nivel secundario ante:
 - Ideación suicida activa.
 - Síntomas psicóticos.
 - Rechazo alimentario o riesgo vital.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Una clasificación inadecuada puede tener **consecuencias clínicas y legales importantes**:

- Tratamientos inefectivos o contraproducentes (p. ej., uso de ISRS en bipolar no diagnosticado).
- Retraso en acceso a GES o programas de rehabilitación.
- Diagnósticos erróneos que estigmatizan al paciente.

En cambio, un diagnóstico correcto:

- Mejora la **respuesta terapéutica**.
- Reduce el **riesgo de recaídas**.
- Facilita el **seguimiento longitudinal** del paciente.

Pronóstico:

Depende de la precisión diagnóstica inicial, adherencia terapéutica y soporte familiar.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **CIE-10 es el sistema oficial en Chile** (usado en APS y hospitales).
2. **DSM-5 es más detallado y clínico**, ideal para formación y examen EUNACOM.
3. Un diagnóstico psiquiátrico **se basa en la descripción clínica**, no en exámenes.
4. Siempre considerar **diagnóstico diferencial orgánico o por sustancias**.
5. En Chile, el GES prioriza diagnósticos como:
 - Depresión (F32–F33)
 - Esquizofrenia (F20)

- Trastorno bipolar (F31)
 - Trastornos de ansiedad (F40–F41)
6. Los **síntomas psicóticos breves (<1 mes)** no implican esquizofrenia.
 7. **Evaluar siempre riesgo suicida y funcionalidad global.**
-



Errores comunes

- Aplicar criterios DSM en ficha clínica (debe usarse CIE-10).
 - No considerar tiempo mínimo de evolución (p. ej., 2 semanas en depresión).
 - Diagnosticar “ansiedad generalizada” sin descartar causa médica.
 - Omitir la evaluación de consumo de sustancias.
 - Usar nombres coloquiales (“trastorno mixto”, “crisis nerviosa”) sin base nosológica.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **CIE-10 (OMS)** y **DSM-5 (APA)** son las clasificaciones psiquiátricas principales.
2. En **Chile**, el **CIE-10** es el sistema oficial (MINSAL / GES).
3. El **DSM-5** es más clínico y específico, útil para EUNACOM y docencia.
4. Ambos sistemas son **descriptivos, no etiológicos**.
5. El diagnóstico psiquiátrico requiere entrevista completa y examen mental.
6. **Confirmar siempre exclusión de causas orgánicas.**
7. Un diagnóstico preciso permite un tratamiento eficaz y reduce el estigma.